14. 체중감소

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022년 기출 · 총 10문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 김아솔

2025년 시험 18번 · 출제자 김아솔

1. 65세 남자가 3개월 동안 10 kg의 체중감소로 왔다. 3개월 전부터 소화가 안되는 증상이 있었으며, 1달 전부터 명치부근이 묵직하게 아프고 통증이 등으로 뻗친다고 하였다. 대변을 보면 기름이 뜨고 물에 잘 씻겨 내려가지 않으며 색깔이 옅어진다고 한다. 키 170 cm, 몸무게 60 kg, 혈압 120/80 mmHg, 맥박 76회/분, 호흡 16회/분, 체온 36.6℃ 이다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 원인감별을 위해 가장 먼저 시행할 영상검사는?

혈색소 11.9g/dL, 백혈구 8,500/mm³, 혈소판 250,000/mm³
공복혈당 180 mg/dL (참고치, <100)
총빌리루빈 2.5 mg/dL (참고치, <1.2)
알칼리성인산염분해효소 350 U/L (참고치, 40-120)
녹말분해효소 65 U/L (참고치, 28-100)
지방분해효소 40 U/L (참고치, 13-60)
CA19-9 850 U/mL (참고치, <37)

① 복부 단순촬영
② **복부 컴퓨터단층촬영**
③ 상부위장관내시경
④ 하부위장관내시경
⑤ 콩팥요관방광단순촬영

> **정답 ②**
> 고령 남성의 체중감소, 소화불량, 등으로 뻗치는 명치 통증, 지방변(기름이 뜨고 잘 안 씻겨 내려감 = 이자 외분비 기능 저하), 새로 생긴 고혈당(공복 180), 폐쇄성 황달(빌리루빈 · ALP 상승), CA19-9 크게 상승(850)은 이자암을 강하게 시사한다. 이자와 주변 혈관 · 림프절 · 간 전이를 함께 평가할 수 있는 복부 CT(이자 프로토콜)가 가장 먼저 할 영상검사다. 내시경은 위 · 대장 점막 질환 감별용이고, 단순촬영은 이자 종괴를 볼 수 없다.

2. 55세 남자가 4개월 동안 6 kg의 체중감소로 왔다. 4개월 전부터 견딜 수 없을만큼 피곤하다고 하며, 특히 밤에 옷이 흠뻑 젖을 정도의 식은땀을 자주 흘린다고 한다. 2주 전 목 왼쪽에서 멍울이 만져지는 것을 발견하였으며, 압통은 없다고 한다. 키 175 cm, 몸무게 68 kg, 혈압 130/80 mmHg, 맥박 86회/분, 호흡 16회/분, 체온 37.8℃ 이다. 왼쪽 목 앞쪽에서 2 cm크기의 단단하며 움직이지 않는 덩이가 만져진다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 원인감별을 위해 시행할 검사는?

혈색소 11.5g/dL, 백혈구 9,800/mm³, 혈소판 280,000/mm³
젖산탈수효소 550 U/L (참고치, 140-280)
적혈구침강속도 80 mm/hr (참고치, <20)

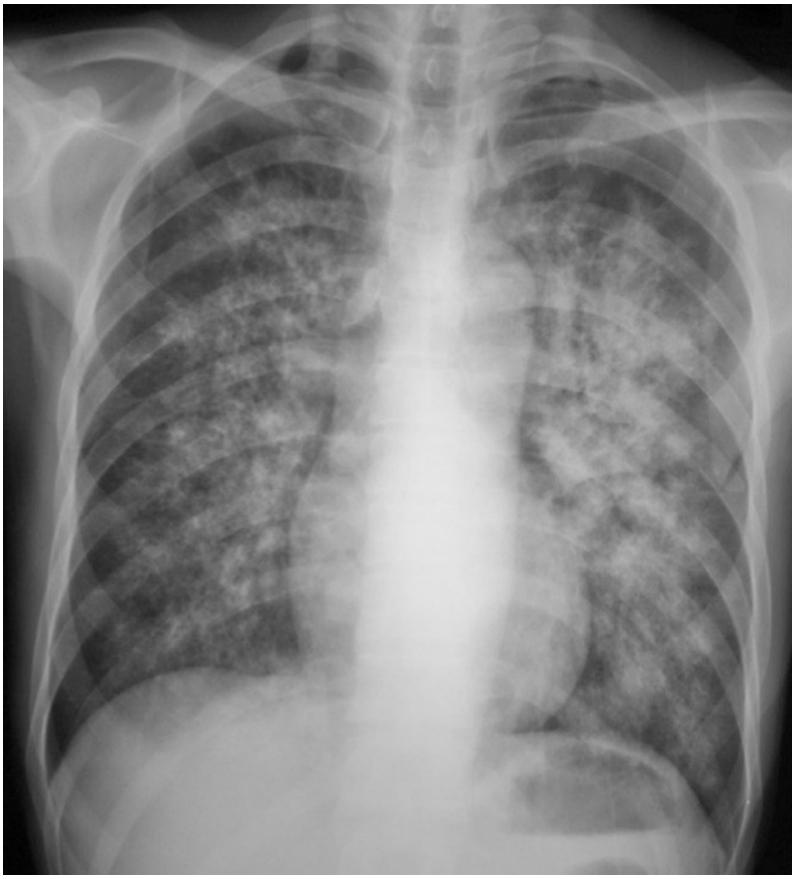
① 가슴 X선검사
② 갑상샘기능검사
③ 앱스타인-바바이러스 항체검사
④ 기관지세포세척검사
⑤ 림프절 절제생검

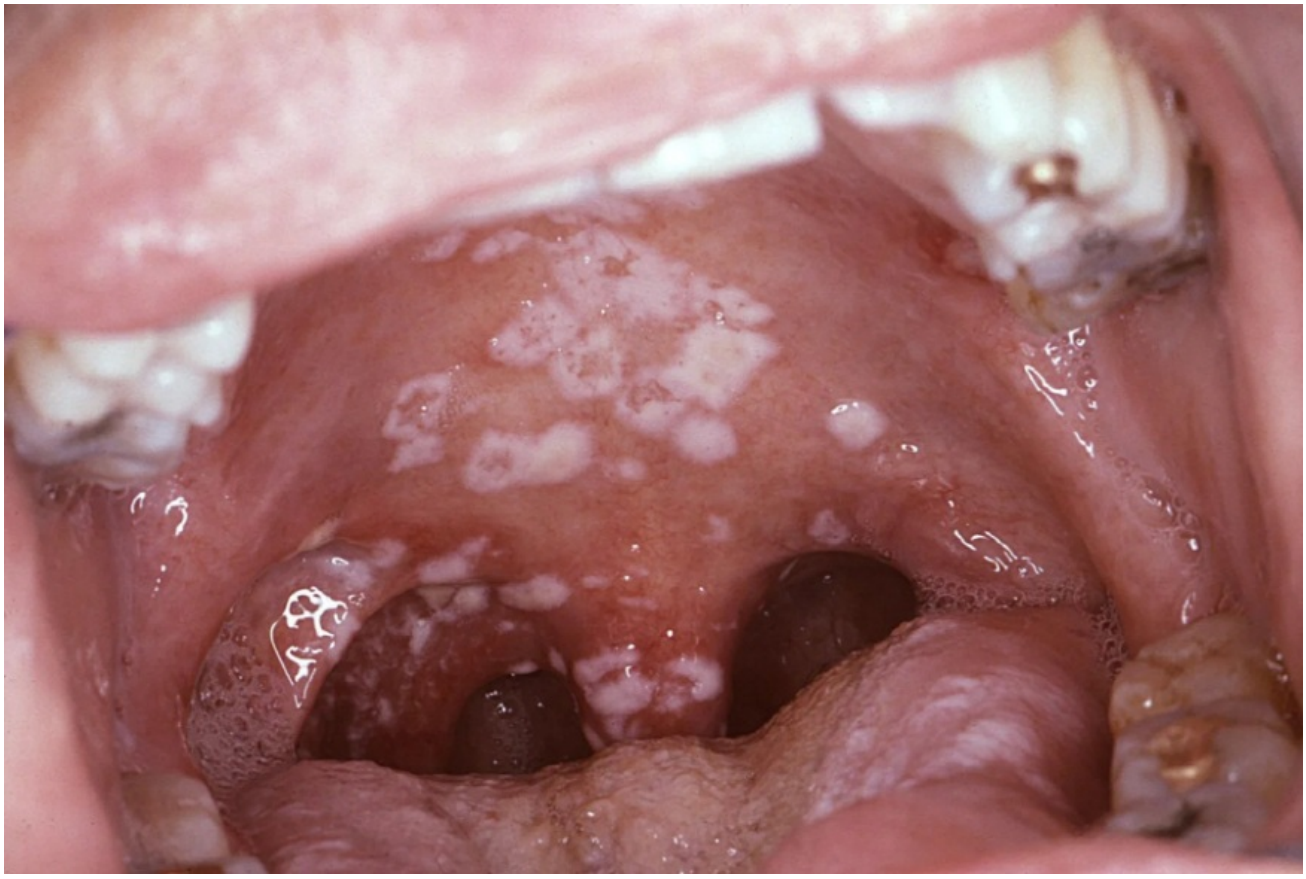
정답 ⑤

발열 · 야간발한 · 체중감소(B 증상), 압통 없이 단단하고 움직이지 않는 목 림프절, LDH 상승, ESR 상승은 악성림프종을 강하게 시사한다. 림프종은 림프절 구조와 세포를 함께 봐야 아형을 진단할 수 있으므로 림프절 절제생검(excisional biopsy)으로 확진한다. 세침흡인만으로는 부족하며, 가슴 X선 · 갑상샘검사 · EBV 항체는 원인 감별을 확정해 주지 못한다.

3. 32세 남자가 4개월동안 12 kg의 체중감소로 왔다. 4개월 전부터 쉽게 피곤하고 입맛이 없었으며 3개월 전부터는 마른 기침이 생겼다고 한다. 2개월 전부터는 계단을 오르면 숨이 차는 증상이 생겼으며, 밤에 잘 때 식은땀이 많이 난다고 한다. 10년 전 친구의 권유로 불법적인 정맥주사(주로 헤로인)을 시작하였으며 이후 약 6년간 비정기적으로 여러 사람들과 함께 약물을 사용한 적이 있다고 한다. 키 178 cm, 몸무게 55 kg, 혈압 110/70 mmHg, 맥박 106회/분, 호흡 24회/분, 체온 37.9℃ 이다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 가슴X선사진과 입안 사진이다. 체중감소의 원인으로 가장 의심되는 질환은?

혈색소 12.0g/dL, 백혈구 3,500/mm³ (림프구 15%), 혈소판 130,000/mm³





① 폐암
② 악성림프종
③ 파종성결핵
④ 감염성심내막염
⑤ 후천성면역결핍증

> **정답 ⑤**
>
> 정맥주사 약물 공동 사용(HIV 감염 위험), 4개월간 12 kg 체중감소, 발열 · 야간발한, 마른기침과 호흡곤란, 백혈구 · 림프구 감소(림프구 15%), 혈소판 감소가 있다. 가슴 X선에서 양측 폐에 미만성 간질성 · 결절성 음영이 보이고, 입안 사진에서 입천장에 흰 반점(구강 칸디다증)이 보인다. 구강 칸디다증과 기회감염성 폐렴(PCP 등)은 세포면역 저하를 뜻하므로, 체중감소의 근본 원인은 후천성면역결핍증(AIDS)이다. 파종성결핵도 비슷한 X선을 보일 수 있지만 구강 칸디다증과 림프구 감소까지 설명하는 진단은 AIDS다.

2024년 시험 20번 · 출제자 김아솔

4. 14세 남아가 살이 빠져서 왔다. 키는 155cm이었다. 원래 몸무게는 44kg이었으나 6개월간 15kg의 체중감소가 있었다. 중학교 1학년 학생으로 입학 후 1달 만에 학교를 가지 않으려고 하였으며, 잦은 설사와 오심, 구토, 복통이 있다. 특히 1달 전 중학교 입학한 후 혼자서 잠을 안자려고 한다거나, 어머니와 한시도 떨어지지 않은 등 퇴행적인 행동을 보였다. 3년 전 환아의 애착 인형을 부모가 버린 직후, 과도하게 울고, 식욕이 떨어지고 구토, 설사, 잦은 복통 호소가 있었으며, 당시 내과 병원 등에서 검사에서는 특별한 소견이 없었다. 1년 정도 후 다소 호전 되어 식사도 하고 지냈으며, 중학교 입학을 준비하는 시기 부터 다시 식욕도 없고 설사와 구토와 복통이 생겼다. 월요일부터 금요일까지는 증상이 심하며, 금요일 이후에는 식사도 하고 소화기증상들도 덜 호소 하였다. 환자의 체중감소 원인 중 가장 의심되는 것은?

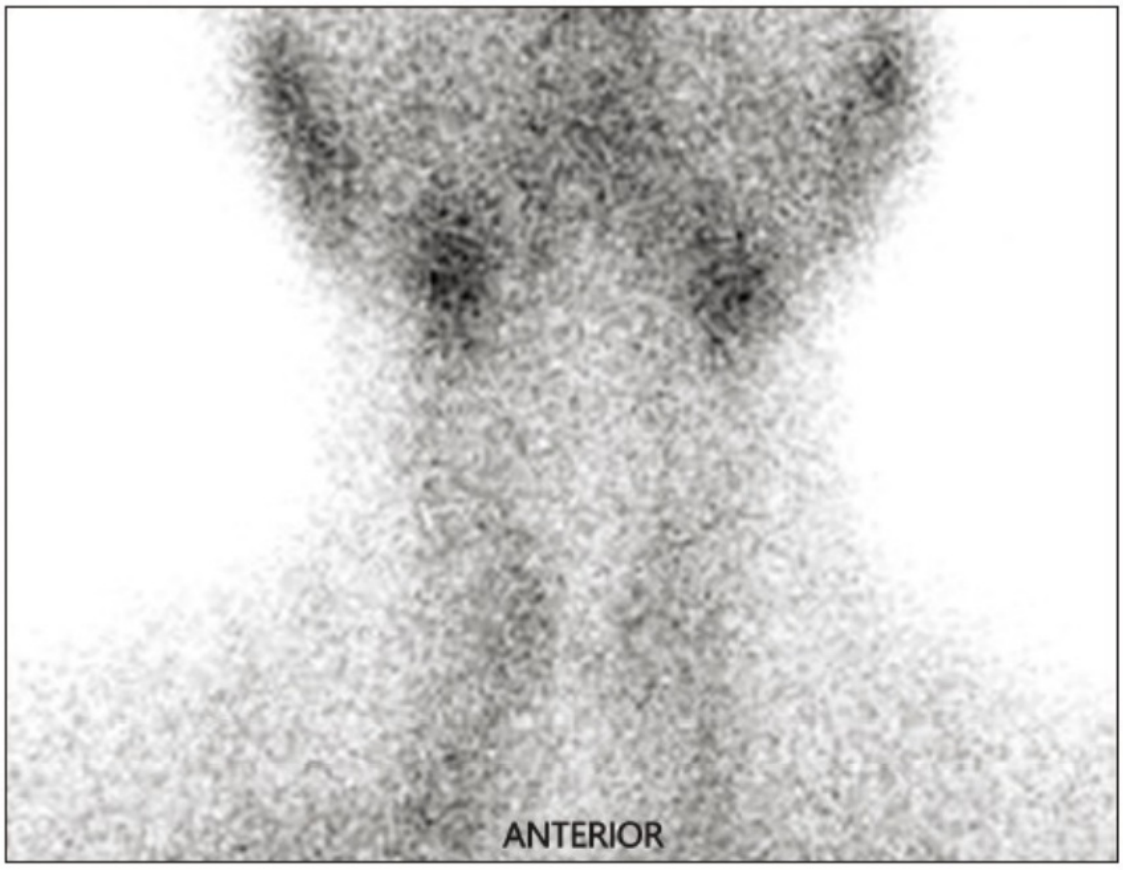
① anorexia nervosa
② bipolar II disorder
③ separation anxiety disorder
④ factitious disorder
⑤ malingering

> **정답 ③**
> 애착 대상(어머니)과 떨어지는 것을 지나치게 두려워하고(혼자 자지 않으려 함, 잠시도 떨어지지 않음), 등교 거부, 학교 가는 평일에 심해지고 주말에 좋아지는 복통 · 구토 · 설사, 애착 인형 상실 뒤 시작된 퇴행 행동은 분리불안장애의 전형적 양상이다. 신경성식욕부진증은 체중 증가에 대한 두려움과 신체상 왜곡으로 일부러 먹지 않는 것이 핵심이며, 인위성장애는 환자 역할을 위해, 꾀병은 외적 이득을 위해 증상을 만들어 낸다.

2023년 시험 14번

5. 28세 남자가 1개월 간 체중이 6 kg 줄었다며 병원에 왔다. 손떨림이 있고 계단을 오르면 숨이 차며 목에 통증은 없다. 키 173 cm, 체중 75 kg, 혈압 112/78 mmHg, 맥박 102회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.7℃이다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 갑상샘 스캔 사진이다. 체중감소의 원인으로 가장 의심되는 진단은?

갑상샘자극호르몬 <0.01 mIU/L (참고치, 0.34~4.25)
유리 T4 3.6 ng/dL (참고치, 0.8~1.7)
갑상샘자극호르몬수용체항체 0.45 IU/L (참고치, 0~1.75)
갑상샘과산화효소항체 1,000 IU/L (참고치, 0~34)



① 그레이브스병
② 아급성갑상샘염
③ 독성결절갑상샘종
④ **하시모토갑상샘염**
⑤ 급성화농성갑상샘염

정답 ④

TSH 억제, 유리 T4 상승으로 갑상샘중독증이다. 갑상샘 스캔에서 갑상샘 섭취가 거의 보이지 않고(침샘만 보임), TSH 수용체 항체는 음성, 갑상샘과산화효소(TPO) 항체는 매우 높으며 목 통증이 없다. 섭취가 낮은 갑상샘중독증은 갑상샘염에 의해 저장된 호르몬이 새어 나온 것이며, TPO 항체가 높고 통증이 없으므로 하시모토갑상샘염(무통성 갑상샘염, 하시톡시코시스)이다. 그레이브스병은 수용체 항체 양성과 미만성 섭취 증가, 아급성갑상샘염은 목 통증 · ESR 상승, 독성결절은 뜨거운 결절, 급성화농성은 발열 · 국소 통증을 보인다.

6. 35세 여자가 2개월 동안 체중이 4 kg 줄어서 병원에 왔다. 키는 160 cm 이며 2달 전 몸무게는 55 kg이었다. 2주 전부터는 배가 불러온다고 하였다. 혈압 110/70 mmHg, 맥박 97회/분,호흡 21회/분, 체온 38.1℃이다. 의식은 명료하다. 배는 팽만하고 이동둔탁음이 있다. 배에 가벼운 압통은 있으나 반동 압통은 없다. 검사결과는 다음과 같다. 체중감소의 원인으로 가장 의심되는 진단은?

혈액:
  혈색소 11.2 g/dL, 백혈구 4,200/mm³, 혈소판 169,000/mm³
  총단백질 6.0 g/dL (참고치, 6.0-8.5), 알부민 3.3 g/dL (참고치, 3.5-5.2)
  총빌리루빈 1.2 mg/dL (참고치, 0.2-1.2)
  아스파르테이트아미노전달효소 34 U/L (참고치, 0-40)
  알라닌아미노전달효소 21 U/L (참고치, 0-33)
  아밀라아제 61 U/L (참고치, 23-110), 리파제 30 U/L (참고치 0-160)
복수:
  백혈구 1,500/mm³ (중성구 5%, 림프구 90%)
  단백질 3.1 g/dL, 알부민 2.5 g/dL
  아데노신탈아미노효소(ADA) 85 U/L
소변:
  단백질 (-), 적혈구 0~2/고배율시야

① 간경화증
② 복막결핵
③ 콩팥증후군
④ 급성이자염
⑤ 복막암종증

정답 ②

젊은 여성의 발열, 체중감소, 복수가 있다. 복수 백혈구 1,500/mm³ 중 림프구 90%, 단백질 3.1 g/dL로 높고, 혈청-복수 알부민 차이(SAAG)가 3.3-2.5=0.8로 1.1 미만(삼출성)이며, 복수 ADA가 85 U/L로 크게 높다. 림프구 우세 삼출성 복수에 ADA 상승은 복막결핵을 강하게 시사한다. 간경화는 SAAG ≥1.1과 낮은 복수 단백, 콩팥증후군은 단백뇨, 급성이자염은 아밀라아제 · 리파아제 상승, 복막암종증은 복수 세포검사에서 암세포를 보인다.

7. 26세 여자가 1달 간 10 kg의 체중감소가 있으며 우울감이 심해 부모님이 데리고 병원에 왔다. 키는 170 cm 이며 1년 전 몸무게는 55 kg이었다. 평소 살을 빼야한다는 스트레스가 심하였다고 한다. 2년 전부터 스트레스를 받고 나면 주체할 수 없이 많이 먹고, 먹은 뒤에는 후회를 하며 손가락을 입에 넣어 구토하기를 반복해왔다. 끼니를 거를 때가 많고 이뇨제와 관장약도 자주 사용해왔다. 체중감소의 원인으로 가장 의심되는 진단은?

① 폭식장애
② 주요우울장애
③ 신경성폭식증
④ 신경성식욕부진증,제한형
⑤ 신경성식욕부진증,폭식/제거형

정답 ③

스트레스 후 통제하지 못하고 폭식한 뒤 후회하며 손가락을 넣어 구토하고, 이뇨제 · 관장약을 사용하는 부적절한 보상행동을 2년간 반복한 것은 신경성폭식증의 핵심 양상이다. 폭식장애는 보상행동이 없고, 주요우울장애만으로는 폭식-제거 행동을 설명하지 못한다.
※ 확인 필요: 1년 전 55 kg에서 10 kg이 줄었다면 현재 약 45 kg(키 170 cm, BMI 약 15.6)으로 심한 저체중이다. DSM-5에서는 유의한 저체중이 있으면 신경성폭식증보다 신경성식욕부진증 폭식/제거형(⑤)을 우선 진단하므로, 출제 의도를 강의 자료로 확인하세요.

2022년

2022년 시험 18번

8. 30세 남자가 1개월간 체중이 5kg 줄어서 병원에 왔다. 혹이 목에서 1개월 전부터 만져졌고, 1~2주 사이에 급격히 커지면서 만지면 아팠다고 한다. 2주 전부터 밤에 땀이 나며 오한이 있었다. 혈압 110/70mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 22회/분, 체온 38.2°C이다. 혹은 오른쪽 목에 있고, 크기는 10 cm 정도 이다. 만질 때 약한 압통이 있다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 가능성이 높은 진단은?

혈색소 12.0 g/dL

백혈구 11,800/mm³ (호중구 47%, 림프구 45%, 단핵구 5%, 호산구 3%, 모세포 0%)

혈소판 180,000/mm³

젖산탈수소효소 800 U/L (참고치, 0~200 U/L)

베타2-저분자글로불린 4.5 mg/L (참고치, 1.1~2.4)

갑상샘자극호르몬 2.0 mIU/L (참고치, 0.34~4.25)

T3 80 ng/dL (참고치, 77~135)

유리 Thyroxine (free T4) 1.0ng/dL (참고치, 0.8~1.7)

① **림프종**
② 당뇨병
③ 그레이브스병
④ 아급성갑상선염
⑤ 하시모토갑상선염

> **정답 ①**
> 빠르게 커지는 큰(10 cm) 목 덩이, 발열 · 야간발한 · 체중감소(B 증상), LDH(800)와 베타2-미세글로불린 상승은 림프종을 시사한다. 갑상샘기능검사(TSH, T3, 유리 T4)가 정상이므로 그레이브스병 · 아급성갑상선염 · 하시모토갑상선염의 가능성은 낮고, 당뇨병은 목 덩이를 설명하지 못한다. 확진은 림프절 생검으로 한다.

9. 72세 남자가 3개월 전부터 체중이 2kg 줄고 소변을 자주 본다고 병원에 왔다. 남동생이 당뇨병으로 약물 치료 중이다. 키 165 cm, 체중 65 kg이다. 혈압 135/72 mmHg, 맥박 72회/분, 호흡 16회/분, 체온 36.7°C이다. 검사 결과는 다음과 같다. 진단은?

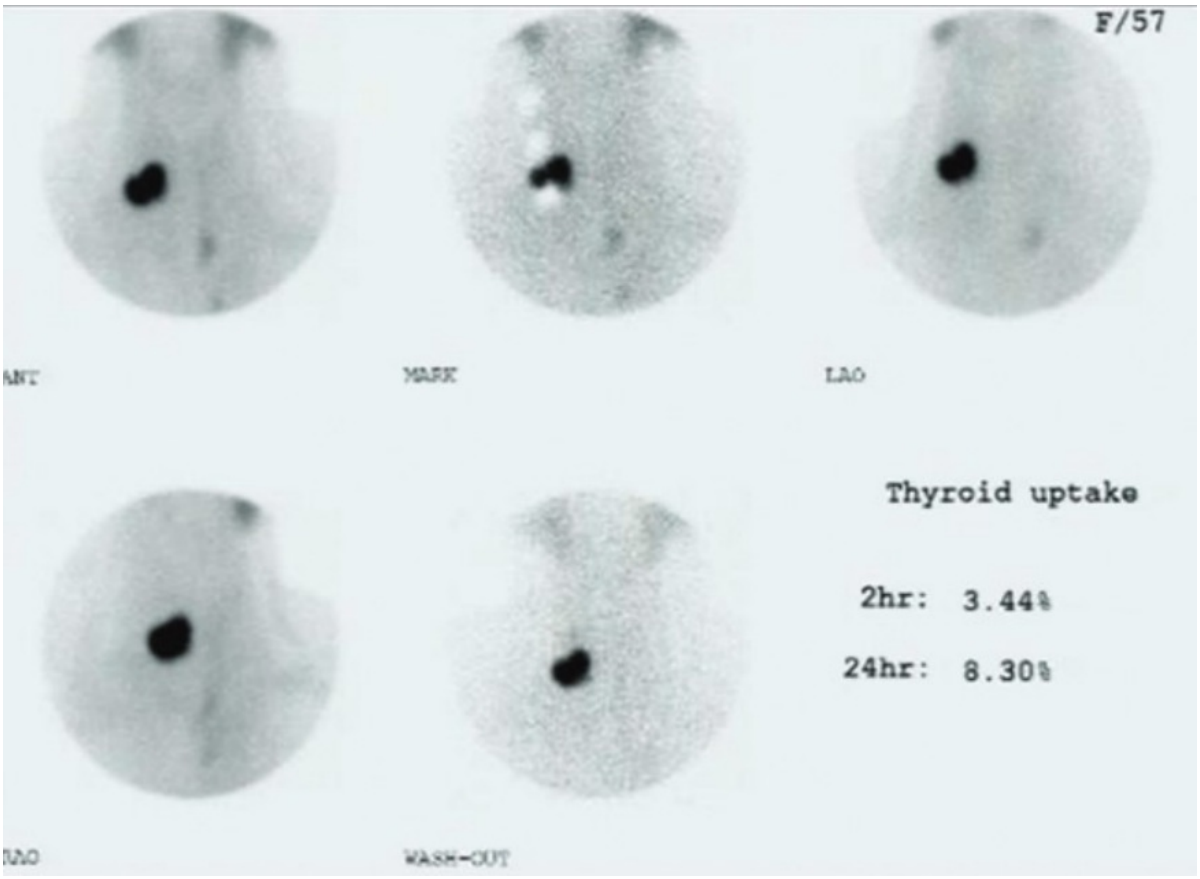
혈액:
혈액요소질소 13 mg/dL, 크레아티닌 0.6 mg/dL
75 g 경구포도당부하검사:
  공복 포도당 112 mg/dL
  2시간 포도당 139 mg/dL
당화혈색소 6.1%
C-펩티드 2.6 ng/mL (참고치, 0.8~3.5)
소변:
포도당 (±), 단백질 (-), 케톤 (-)

① 정상
② 당뇨병
③ 그레이브스병
④ 공복혈당장애
⑤ 크롬친화세포종

정답 ④

공복혈당 112 mg/dL(100~125)는 공복혈당장애, 경구포도당부하 2시간 혈당 139 mg/dL(<140)는 정상, 당화혈색소 6.1%(5.7~6.4)는 당뇨병 전단계에 해당한다. 당뇨병 진단 기준(공복 ≥126, 2시간 ≥200, 당화혈색소 ≥6.5%)에는 미치지 않으므로 공복혈당장애다. 2 kg 정도의 체중감소와 빈뇨는 비특이적이며 갑상샘 질환이나 크롬친화세포종을 시사하는 소견이 없다.

10. 57세 여자가 3개월 전부터 체중이 5kg 줄어서 (60kg에서 55kg) 병원에 왔다. 체중이 줄면서 손이 많이 떨린다고 한다. 혈압 150/89 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.7°C이다. 앞목에 2 cm 덩이가 부드럽게 만져 지며 압통은 없고 덩이는 잘 움직였다. 갑상샘스캔 사진이다. 검사 결과는 다음과 같다. 가능성이 높은 진단은?



T3 352 ng/dL (참고치, 77~135)
유리 Thyroxine (free T4) 3.2 ng/dL (참고치, 0.8~1.7)
갑상샘자극호르몬 0.01 mIU/L (참고치, 0.34~4.25)
갑상샘자극호르몬수용체항체 0.8 mIU/mL (참고치, ≤1.75)

① 독성갑상샘종
② 그레이브스병
③ 아급성갑상선염
④ 하시모토갑상선염
⑤ 인공적 갑상선중독

정답 ①

T3 · 유리 T4 상승, TSH 억제로 갑상샘중독증이고, 앞목에 압통 없이 잘 움직이는 2 cm 결절이 있다. 갑상샘 스캔에서 결절 한 개만 진하게 섭취되고(뜨거운 결절) 나머지 갑상샘은 억제되어 보이지 않으며, TSH 수용체 항체는 음성이다. 따라서 자율적으로 호르몬을 만드는 독성갑상샘종(독성 선종, Plummer병)이다. 그레이브스병은 수용체 항체 양성과 미만성 섭취 증가, 아급성 · 하시모토 갑상선염과 인공적 갑상선중독은 섭취가 전반적으로 감소한다.